

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et de la sécurité du travail)

Région : Abitibi-Témiscamingue

Dossier : 586662-08-1510

Dossier CNESST : 500681275

Rouyn-Noranda, le 12 août 2016

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : Josée Audet

France Dionne
Partie demanderesse

et

O.P.C. Déli
Alimentation Gaétan Plante inc.
Parties mises en cause

et

**Commission des normes, de l'équité,
de la santé et de la sécurité du travail**
Partie intervenante

DÉCISION

[1] Le 6 octobre 2015, madame France Dionne, la partie demanderesse, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 25 août 2015, à la suite d'une révision administrative.

[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu'elle a initialement rendue le 14 juillet 2015 et déclare irrecevable la réclamation de la travailleuse.

[3] Le 1^{er} janvier 2016, la *Loi instituant le Tribunal administratif du travail*¹ (la LITAT) est entrée en vigueur. Cette loi crée le Tribunal administratif du travail qui assume les compétences de la Commission des relations du travail et de la Commission des lésions professionnelles. En vertu de l'article 261 de cette loi, toute affaire pendante devant la Commission des relations du travail ou devant la Commission des lésions professionnelles est continuée devant la division compétente du Tribunal administratif du travail.

[4] De plus, depuis le 1^{er} janvier 2016, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) assume les compétences autrefois dévolues à la CSST.

[5] La présente décision est donc rendue par le soussigné en sa qualité de membre du Tribunal administratif du travail.

[6] Une audience est tenue à Val-d'Or le 12 juillet 2016, en présence de la travailleuse, de sa représentante et du représentant de la partie intervenante. Il a été convenu que l'audience n'allait concerner que la question préliminaire du délai de réclamation et le dossier a été mis en délibéré à cette date.

L'OBJET DE LA QUESTION PRÉLIMINAIRE

[7] La partie intervenante présente une objection préliminaire voulant que la réclamation de la travailleuse n'ait pas été faite à l'intérieur des délais prévus à la loi et qu'elle n'ait fait la démonstration d'aucun motif raisonnable permettant de la relever de son défaut.

LES FAITS SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE

[8] Le Tribunal se bornera à résumer les faits relatifs à la question préliminaire, ceux-ci étant suffisants pour trancher le présent litige.

[9] En 2011, la travailleuse subit une lésion professionnelle à la cheville, en raison de laquelle elle conserve un droit à des indemnités réduites de remplacement de revenu.

¹ RLRQ, c. T-15.1.

[10] En 2014, la travailleuse est serveuse pour l'employeur. Le 1^{er} septembre 2014, elle consulte son médecin la docteure Paule Bergeron. Cette dernière signe un certificat médical où elle indique que la travailleuse est en arrêt de travail pour raisons médicales.

[11] La longue note de consultation de la docteure Bergeron de cette date fait état de multiples problèmes de santé. Le premier mentionné réfère à la lésion professionnelle subie par la travailleuse en 2011, et commence comme suit : « CSST du 2011-11-17 avec ex. cheville gauche. Douleur et inconfort de plus en plus [...] ».

[12] Le deuxième point inscrit à la note de consultation réfère à des radiographies sans autre détail. Le troisième élément noté par le médecin indique que la travailleuse a des problèmes d'insomnie en partie dus à ses douleurs.

[13] Le dernier problème de santé figurant à la note de consultation concerne les douleurs aux épaules de la travailleuse. Cette partie de la note débute comme suit :

Tendinite épaule D [droite] de longue date évolution sur des années possiblement augmentées par le travail. Pte [patiente] n'arrive plus à bouger les épaules. Épaules pratiquement gelées actuellement. Radio épaule droite=dépôts calcaires ds t. du sus-épineux prob.

[...]

[14] L'impression diagnostique est tendinite et bursite calcifiées, et le médecin recommande arrêt de travail, traitements et médication.

[15] Il n'y est pas question de causes, de gestes au travail particulièrement, ni d'aucune mention qui réfère d'une façon ou d'une autre à la CSST.

[16] À compter du 11 septembre 2014, la travailleuse a des communications avec une agente d'indemnisation de la CSST, dont le compte rendu figure au dossier.

[17] Le 11 septembre 2014 donc, l'agente de la CSST, responsable du dossier de la travailleuse, note ce qui suit:

Titre : Réception certificat du Dre Paule Bergeron #85192.

ASPECT MÉDICAL :

- un arrêt de travail du 31 août au 8 septembre 2014/tendinopathie et bursite épaule droite (condition personnelle)
- Réception d'un deuxième certificat médicale du Dr Paule Bergeron.
- un arrêt de travail indéterminée à partir du 8 septembre 2014/ raison médicale et doit être réévalué tous les jours.

ASPECT FINANCIER :

Donc, indemnité autorisée, T [la travailleuse] est avisée indemnité réduite à partir du 15 octobre 2014.

[sic]

[18] La travailleuse poursuit son suivi médical et ses communications avec l'agent(e) de la CSST.

[19] Ainsi, le 14 octobre 2014, l'agent(e) écrit :

Titre : message de la T par la CRCA²/irr [indemnités de remplacement du revenu] réduites à partir du 15 octobre 2014.

-ASPECT FINANCIER :

Appel fait à la T, pas de réponse donc nous lui laissons le message qu'à partir du 15 octobre elle recevra 8.07\$ /jour soit 112.98\$ aux deux semaines.

[20] Le 9 mars 2015, l'agent(e) indique cette fois dans ses notes évolutives :

Titre : message de la T par le CRCA/

-ASPECT MÉDICAL

Message reçu : « T dit qu'elle a contracté une bactérie en Septembre au visage et elle a été hospitalisée jusqu'au 21 Septembre 2014.

T a eu un suivi et continue [à] en avoir.

T dit qu'elle était en assurance chômage maladie mais celle-ci a cessé après 15 semaines donc elle voudrait vous en parler à ce sujet ».

Appel fait à la T, nous l'avisons que la CSST lui verse des irrs réduites et ne peut payer pour sa condition personnelle. T nous dit comprendre et n'a pas d'autres questions.

[...]

[21] Plus tard, à compter du 9 septembre 2014, on peut lire aux notes évolutives du dossier de la CSST que la travailleuse est en arrêt de travail pour une condition que l'agent(e) de la CSST indique comme étant une condition personnelle et que la travailleuse souffre de divers problèmes de santé, dont un problème à la cheville.

[22] La travailleuse témoigne à l'audience. Elle explique que son médecin cherchait la cause de ses douleurs aux épaules et que ce n'est qu'en avril 2015 qu'elle a fait le lien avec son travail, ce qui explique la date de sa réclamation. Elle ajoute qu'elle a dû être hospitalisée en 2014 en raison d'une bactérie au visage.

[23] Selon la travailleuse, elle aurait communiqué à une ou deux reprises avec la CSST en appelant le CRCA et le motif de ses appels était de savoir ce qu'elle avait le droit de recevoir en vertu du régime fédéral d'assurance-emploi, étant donné qu'elle recevait des indemnités réduites de remplacement du revenu. À la suite du message qu'elle laissait au CRCA, son agente la rappelait.

[24] La travailleuse est catégorique au sujet du fait qu'aucun préposé à la Commission, que ce soit l'agente responsable de son dossier ou le préposé aux renseignements du CRCA, personne ne lui a jamais recommandé de faire une réclamation à la Commission. Il était davantage question de ses revenus que de la cause de ses problèmes de santé.

[25] Les certificats médicaux complétés par la docteure Bergeron entre septembre 2014 et janvier 2015 indiquent que la travailleuse est en arrêt de travail pour « raisons médicales » sans plus et les notes de consultation n'évoquent jamais ni de lien précis avec le travail ni la CSST.

[26] Le 6 avril 2015, la travailleuse voit la docteure Bergeron qui note pour la première fois :

[...]

Plan : Déclarons à la CSST

- maladie professionnelle probable.
- coiffure x plusieurs années
- épicerie x environ 3-4 ans (à la caisse)
- restauration depuis 2009, (cabarets etc)



En AT [arrêt de travail] depuis 1^{er} sept. Suite à infiltration d'épaule droite.

[...]

[nos soulignements]

[27] Et la docteure Bergeron signe le même jour pour la première fois une attestation médicale CSST où elle indique :

- Tendinite calcifiée]
- bursite calcifiée]
- infiltrées 01-09-2014]
- Tendinite calcifiée]
- épaule gauche]
- = maladie professionnelle
- (> mvts répétitifs, charges etc)
- Détérioration des épaules

[28] La travailleuse explique enfin qu'elle a logé sa réclamation à la CSST après que la docteure Bergeron lui ait dit qu'elle croyait que ses douleurs étaient dues à son travail.

[29] La réclamation de la travailleuse est reçue à la CSST le 17 avril 2015. Questionnée sur les raisons de sa réclamation, la travailleuse dit à l'agente de la CSST, une agente différente de celle avec qui elle a eu des conversations entre septembre 2014 et mars 2015 :

[...]

T me dit qu'elle a été retardé pour faire sa réclamation, parce qu'elle aurait été hospitalisée du 11 au 21 septembre 2015 (10 jours). Aussi elle dit avoir fait beaucoup d'intolérance à des médicaments qu'elle devait prendre.

Par la suite, elle dit qu'elle était étourdie, qu'elle ne pouvait pas écrire, qu'elle n'avait pas la tête à sa... [sic]

T aurait été sur le chômage maladie. À la fin de son chômage, il lui aurait été mentionné qu'elle pouvait faire une réclamation à la CSST puisqu'elle n'avait plus de revenu.

T me dit être travaillante, et qu'elle avait travaillé le plus longtemps possible, parce qu'elle devait travailler.

[...]

[30] La CSST refuse la réclamation de la travailleuse le 14 juillet 2015, au motif qu'elle a été logée hors délai. La travailleuse a contesté cette décision, d'où le présent litige.

[31] La travailleuse dépose en preuve une lettre signée par la docteure Bergeron en date du 27 juin 2015, laquelle le Tribunal juge pertinent de reproduire au complet :

Je désire par la présente apporter quelques précisions sur le dossier de M^{me} France Dionne concernant la déclaration CSST de tendinites d'épaules droite et gauche du 6 avril 2015. J'ai évalué madame Dionne à ce sujet les 1^{er} septembre 2014, 28 novembre 2014, 27 février 2015. 6 avril 2015 et plus.

Le 1^{er} septembre 2014, je notais que madame Dionne éprouvait de la douleur d'épaule droite depuis longtemps mais que la douleur s'était exacerbée depuis quelque temps. Elle avait peine à faire son travail de serveuse en restauration. Cependant, il n'y avait pas eu d'accident de travail précis comme tel. J'ai effectué une infiltration cortisonnée d'épaule droite et j'ai recommandé un arrêt de travail de quelques jours à quelques semaines. La radiographie faite cette même journée démontrait de l'arthrose et des foyers de calcifications, des tissus mous compatibles avec des signes de tendinopathie calcifiante. Puis, j'ai référé madame en physiothérapie pour effectuer des traitements d'ontophorèse ayant pour but de minimiser les dépôts calcaires et ainsi diminuer la douleur et les limitations fonctionnelles.

Puis, j'ai réévalué madame le 28 novembre 2014 et j'ai redemandé des radiographies d'épaule droite de contrôle post-traitements d'ontophorèse. Madame était alors trop souffrante et symptomatique pour autoriser un retour au travail. C'est aussi à ce moment que j'ai décidé d'investiguer l'épaule gauche parce que madame Dionne me signalait les mêmes symptômes qu'à l'épaule droite. La radiographie d'épaule gauche du 3 décembre 2014 démontrait également de gros dépôts calcaires tendineux. La référence fut également faite en physiothérapie pour l'épaule gauche.

Puis, ai réévalué madame le 6 avril 2015 et j'ai porté une attention plus soutenue au sujet de ses épaules. Ce n'est qu'à ce moment que j'ai réalisé la probabilité d'un lien causal entre la vie professionnelle depuis les années précédentes et l'atteinte des épaules de madame. Par le fait même, ce n'est à cet instant que j'ai déclaré l'état de madame comme étant le résultat de mouvements répétitifs, forçants, et souvent à bout de bras qui ont amené les tendinopathies des épaules droite et gauche.

Je désire porter votre attention sur la présence des calcifications qui témoignent de la chronicité de l'inflammation des épaules. Ceci me semble logiquement en lien avec les types de professions exercés par madame au courant des dernières années. D'autant plus que je sais que madame est une grande travaillante et qu'elle est toujours prête à faire de plus longues périodes de travail pour accommoder clientèle ou employeurs.

Également, durant la période de septembre 2014 à avril 2015, madame Dionne a présenté d'autres problèmes de santé, suffisamment sévères pour l'hospitaliser. C'est ainsi que j'ai délaissé son problème d'épaules pendant quelque temps, mon attention étant dirigée sur ses autres problèmes de santé. Somme toutes, ceci résume pourquoi je n'ai fait le lien que le 6 avril 2015 entre les pathologies d'épaules de madame et les emplois qu'elle a occupés. C'est donc pourquoi je n'ai formulé mon impression que le 6 avril 2015.

J'espère que ces informations vont apporter quelques éclaircissements sur le dossier médical de madame.

[nos soulignements]

[32] Enfin, madame Ibtissan Akiki témoigne pour la partie intervenante par le biais de la visioconférence. Chef d'équipe aux relations avec la clientèle au CRCA de la Commission à Montréal, elle connaît bien l'emploi de préposé aux renseignements, emploi qu'elle a elle-même occupé pendant quelques années. Son travail consiste maintenant à former, supporter et accompagner les préposés aux renseignements, dont

le rôle est d'accueillir la clientèle, évaluer ses besoins, lui donner les renseignements nécessaires et l'informer de ses droits et de ses obligations.

[33] Le témoignage de madame Akiki permet de conclure que lorsqu'un travailleur demande des informations aux préposés du CRCA, c'est d'abord à leur médecin que ces préposés les réfèrent. Ces derniers avisent les travailleurs qu'ils doivent aller voir leur médecin, compléter une réclamation, référer au site de lésion atteint et envoyer les documents à la Commission le plus tôt possible.

[34] Le témoin explique également que dans le doute, les préposés recommandent aux travailleurs d'envoyer tous les documents qu'ils détiennent à la Commission. Mais en contre-interrogatoire, elle répète que c'est au médecin traitant que les préposés réfèrent d'abord les travailleurs.

LES MOTIFS

[35] Le Tribunal doit déterminer si la réclamation de la travailleuse est recevable.

[36] La *Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles*³ prévoit un délai pour présenter une réclamation pour maladie professionnelle à son article 272 qui se lit comme suit :

272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

1985, c. 6, a. 272.

[37] Cette question du moment de la connaissance par le travailleur qu'il est atteint d'une maladie professionnelle a fait l'objet de nombreuses décisions de la Commission des lésions professionnelles et maintenant du présent Tribunal.

[38] En effet, dans l'affaire *Chabot et Shermag inc.*⁴, la Commission des lésions professionnelles enseigne que :

³

RLRQ, c. A-3.001.

[99] Le présent tribunal adhère à ce dernier courant. En effet, le texte même de l'article 272 utilise les mots « où il est porté à la connaissance du travailleur ». Cette expression réfère donc à l'existence d'une source externe d'information puisqu'un travailleur ne peut porter quelque chose à sa propre connaissance. Si le législateur avait voulu qu'il en soit autrement, il aurait utilisé, comme aux articles 270 et 271, la date de survenance de la lésion comme point de départ du délai. Le législateur a prévu spécifiquement une exception à l'article 272 à cause de la nature même de la maladie professionnelle dont l'existence et la relation avec le travail s'imposent moins à l'esprit d'un profane que la survenance d'un accident du travail. Si le législateur avait voulu faire dépendre le départ du délai de l'article 272 de la connaissance propre du travailleur, il aurait inscrit à l'article 272 que le délai commençait dans les six mois de la date où le travailleur a connaissance qu'il est atteint d'une maladie professionnelle plutôt que de l'expression « où il est porté à la connaissance du travailleur ».

[100] Il est donc logique que le délai de réclamation ne commence à courir qu'à partir du moment où il est médicalement établi et porté à la connaissance du travailleur qu'il est atteint d'une maladie professionnelle.

[101] Le tribunal est donc d'avis que le délai prévu à l'article 272 commence à courir à partir du moment où la relation possible entre la maladie et le travail est établie médicalement et/ou le travailleur en est informé par son médecin. Peu importe que lui-même ou quelqu'un de son entourage pense qu'il puisse s'agir d'une maladie liée au travail, tant que la relation possible entre la maladie et le travail n'a pas été établie par un médecin qui en a informé le travailleur, on ne peut considérer qu'il a été porté à la connaissance du travailleur que sa maladie est ou peut être liée au travail. Il s'agit alors de spéculations et non de connaissances.

[102] Le tribunal rejoint donc le courant jurisprudentiel qui affirme que le point de départ du délai de l'article 272 est le moment où un médecin a informé le travailleur de la possibilité que sa maladie soit d'origine professionnelle

[...]

[nos soulignements]

[références omises]

[39] Plus récemment, la Commission des lésions professionnelles, dans l'affaire *Lemay et A. & D. Prévost inc.*⁵ rappelle que :

La perception du travailleur quant à l'origine de sa maladie n'est pas suffisante en preuve pour la reconnaissance d'une lésion professionnelle. À plus forte raison, cette même perception ne peut donc servir de point de départ du délai prévu à l'article 272 de la loi. Le critère de la connaissance doit s'analyser en fonction de l'ensemble des faits incluant les éléments médicaux. Le tribunal devra alors déterminer si une personne raisonnable, placée devant ces mêmes faits, peut conclure qu'elle est atteinte d'une maladie causée par son travail.

⁴ C.L.P. 116061-04B-9905, 24 janvier 2003, J.-F. Clément.

⁵ 2012 QCCLP 2007.

[nos soulignements]

[citations omises]

[40] En l'espèce, la preuve révèle que ce n'est qu'en avril 2015 que la travailleuse a été mise au courant par son médecin qu'elle était atteinte d'une maladie professionnelle.

[41] D'abord, de l'avis du Tribunal, la mention aux notes cliniques de la docteure Bergeron du 1^{er} septembre 2014 voulant que la douleur était « possiblement aggravée par le travail » ne permet pas de conclure que la docteure Bergeron fait du travail la cause des symptômes de la travailleuse. D'ailleurs, ses notes cliniques n'évoquent pas le lien avec le travail ni la CSST avant avril 2015. Alors que lorsque la docteure Bergeron évoque en septembre 2014 les problèmes à la cheville de la travailleuse, qui sont en rapport avec une lésion professionnelle reconnue en 2011, elle commence sa note avec la mention « CSST ». Or, le seul endroit où l'on retrouve la mention « CSST », lorsqu'il est question des problèmes aux épaules de la travailleuse, est le 6 avril 2015.

[42] De toute façon, même en tenant pour acquis que la note de la docteure Bergeron est équivoque, ce que le Tribunal ne fait pas, sa lettre du 30 juin 2015, elle, est claire : ce n'est que le 6 avril 2015 qu'elle a pu confirmer à la travailleuse son impression clairement à la travailleuse, pour les raisons qu'elle y explique. Le Tribunal retient ces déclarations de la docteure Bergeron, qui sont confirmées par les propos de la travailleuse en audience.

[43] De plus, la lecture des notes évolutives du dossier de la CSST nous apprend que les questions de la travailleuse à l'agente de la CSST entre septembre 2014 et mars 2015 ont davantage rapport avec ses revenus, et la possibilité pour elle de recevoir des prestations de l'assurance-emploi en même temps que ses indemnités réduites de remplacement du revenu.

[44] En effet, jamais on ne lit dans les notes évolutives faites au cours de cette période que la travailleuse fait le lien entre ses douleurs et son travail avant le 6 avril 2015, jour de la première attestation médicale CSST signée par la docteure Bergeron.

[45] Au cours de la période entre septembre 2014 et mars 2015, tant le contenu des notes évolutives du dossier de la CSST, que celles de la docteure Bergeron, tout indique que le médecin ne faisait pas alors le lien avec le travail et la lésion de la travailleuse, ce qui explique qu'elle ne complète pas d'attestation médicale et que l'agente au dossier réfère constamment à une condition personnelle. Cela rend compréhensible le fait que ni les préposés de la Commission ni ceux du CRCA n'ont

recommandé à la travailleuse de faire une réclamation à la Commission. Et tout ceci concorde à la fois avec le témoignage de la travailleuse et celui de la chef d'équipe de la Commission.

[46] Car en effet, nulle part aux notes évolutives de cette époque dans le dossier de la travailleuse, on ne lit que l'agente recommande à la travailleuse de faire une réclamation. Et, selon le chef d'équipe de la Commission, le préposé aux renseignements doit référer les travailleurs vers leur médecin traitant, ce qui dans l'affaire en l'espèce ne peut mener la travailleuse à faire une réclamation avant le 1^{er} avril 2015.

[47] La chef d'équipe de la Commission a également témoigné à l'effet que dans le doute, les préposés aux renseignements recommandent aux travailleurs de faire une réclamation et de tout envoyer à la Commission. Or, rien dans la preuve au dossier ne permet de conclure que c'est ce qu'un tel préposé a dit à la travailleuse, si l'on se fie aux notes évolutives du dossier, qui démontrent que le CRCA ne faisait que transmettre à l'agente de la CSST le message de la travailleuse, agente qui procédait par la suite à rappeler la travailleuse.

[48] Le Tribunal en conclut que ce n'est que le 6 avril 2015 qu'il a été porté à la connaissance de la travailleuse qu'elle était, selon son médecin, atteinte d'une maladie professionnelle. Dans ce contexte, la réclamation de la travailleuse, reçue à la CSST le 17 avril 2015, est recevable.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

ACCUEILLE la requête de la partie demanderesse, madame France Dionne;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 25 août 2015 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE RECEVABLE la réclamation de la partie demanderesse, madame France Dionne;

CONVOQUERA les parties pour la tenue d'une audience sur le fond du litige.

Josée Audet

M^e Marianne Dessureault
DESROCHES, MONGEON
Pour la partie demanderesse

M^e Maxime Gagné
PAQUET TELLIER
Pour la partie intervenante

Date de la dernière audience : 12 juillet 2016